

LESIONES DEL MIEMBRO SUPERIOR: PATOLOGÍA DEL CODO

A. Roces Fernández, G. Alonso Claro, R. Marcos Mesa.



Radiografías anteroposterior y lateral de codo normales.

LUXACIÓN DEL CODO

2ª Articulación que más frecuentemente se luxa en adultos.

Mecanismo lesional: la mayoría ocurren tras caídas sobre la mano con el codo parcialmente extendido. La más frecuente es la luxación posterior. Se asocian con frecuencia a fracturas de la cabeza radial y de la apófisis coronoides (Triada terrible).

Exploración física: deformidad, dolor y limitación funcional. Pérdida de la morfología del triángulo de Nelaton (triángulo equilátero formado por el olecranon – epitroclea – epicóndilo).

- Descartar lesiones del nervio cubital y del nervio mediano, por tracción.
- Descartar lesión del nervio interóseo anterior (hacer una “O” con el segundo y tercer dedo de la mano).
- Vigilar síndrome compartimental y estado vascular distal.

Pruebas complementarias: Radiografía codo anteroposterior y lateral.

Tratamiento: reducir lo antes posible.

Luxación posterior: método de Parvin, paciente decúbito prono con el codo en flexión se tracciona longitudinal y se presiona sobre el olecranon hacia abajo.

Luxación anterior: tracción más presión hacia atrás y abajo del antebrazo. Tras reducción comprobar de nuevo el estado neurovascular distal, comprobar la estabilidad forzando el varo-valgo y la existencia de bloqueos articulares. Repetir radiografía tras reducción. Si fracturas asociadas o codo inestable tratamiento quirúrgico. Si no existen lesiones óseas ni bloqueos y la articulación es estable, tratamiento conservador, mediante cabestrillo o férula braquiopalmar.



Luxación posterior de codo con fractura de cúpula asociada



Luxación posterior de codo con fractura de cúpula asociada

FRACTURA DE OLÉCRANON

Mecanismo lesional: por traumatismo directo o por fractura-arrancamiento (por la fuerza que genera el tendón del tríceps en una caída con el codo semiflexionado).

Exploración física: hemartros, dolor, deformidad y limitación funcional, sobre todo para la extensión activa.

- En ocasiones se puede palpar la discontinuidad del cúbito.
- Explorar el nervio cubital (parestesias en 5º y 4º dedos).

Pruebas complementarias: Radiografía codo anteroposterior y lateral.

Tratamiento: la mayoría precisan tratamiento quirúrgico. En caso de fracturas no desplazadas o pacientes con alto riesgo quirúrgico, tratamiento conservador mediante férula braquiopalmar a 120º



FRACTURA DE CÚPULA RADIAL

Mecanismo lesional: caída sobre la mano con el codo en extensión.

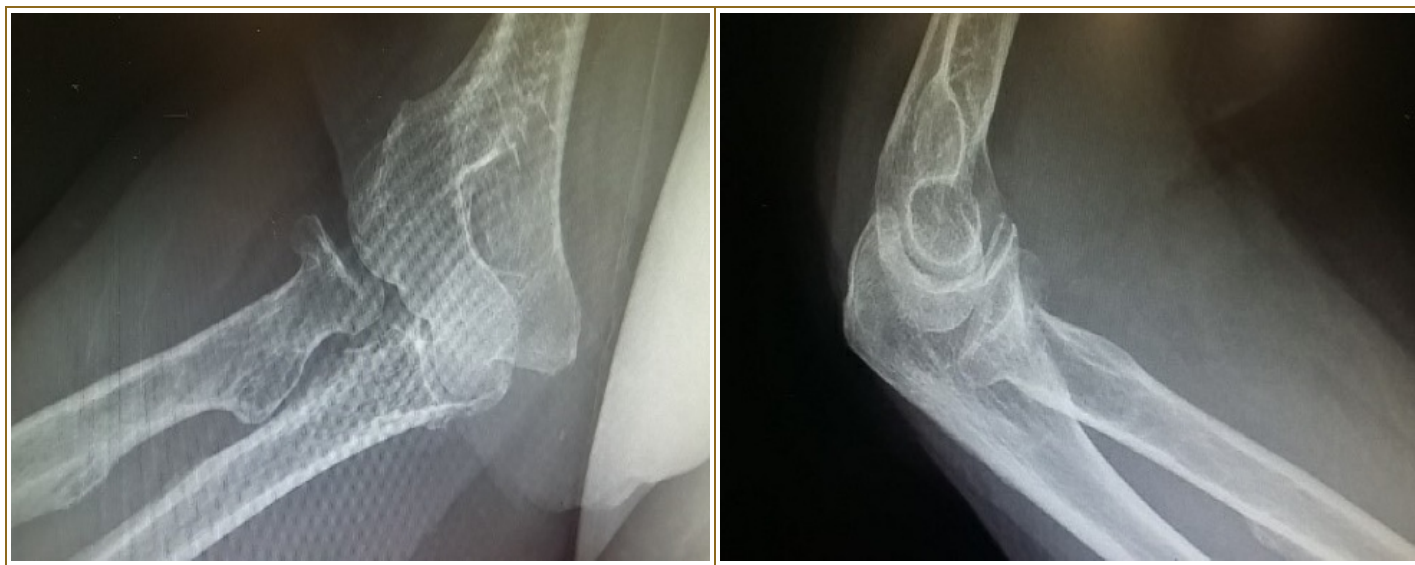
Exploración física: limitación por dolor a la flexo-extensión y sobre todo a la prono-supinación.

- Dolor a la palpación de la cabeza radial.
- Descartar lesiones a nivel del carpo y articulación radiocubital distal.
- Comprobar que no hay bloqueos articulares y que el codo es estable

Pruebas complementarias: Radiografía codo anteroposterior y lateral.

Clasificación: subcapitales o parcelarias (intraarticulares).

Tratamiento: si fracturas no desplazadas y no bloqueo articular, tratamiento conservador mediante férula braquioplamar / cabestrillo. Si fracturas desplazadas, con escalón intraarticular > 2mm o existencia de bloqueo articular, tratamiento quirúrgico.



Fractura parcelar de cúpula radial. Subsidiaria de tratamiento quirúrgico (escalón intraarticular > 2mm)

FRACTURAS DE LA CABEZA RADIAL



CLASIFICACIÓN DE MASON		TRATAMIENTO
MASON I	FRACTURA MARGINAL DE LA CABEZA O FRACTURA DEL CUELLO SIN DESPLAZAR	TRATAMIENTO ORTOPÉDICO CABESTRILLO + ANALGESIA + MOVILIZACIÓN PRECOZ
MASON II	FRACTURA PARCIAL DE LA CABEZA CON MÍNIMO DESPLAZAMIENTO O FRACTURA DEL CUELLO POCO DESPLAZADA O ANGULADA	NO BLOQUEO ARTICULAR A LA EXPLORACIÓN
MASON III	FRACTURA DESPLAZADA O COMMUNUTA DE CABEZA RADIAL O DE CUELLO	SÍ → TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
MASON VI	CUALQUIER FRACTURA DE CABEZA RADIAL ASOCIADA A LUXACIÓN DE CODO	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Normalmente presentan inestabilidad de codo al asociar otras lesiones

Fractura cabeza radial

ROTURA TENDÓN DEL BICEPS

Mecanismo lesional: en pacientes de 40-50 años, tras un sobreesfuerzo al tratar de coger algo pesado.

Exploración física: dolor agudo, chasquido y limitación funcional para la flexión del codo y la supinación. Se aprecia un ascenso de la “bola” y no se palpa bien la inserción del tendón.

Pruebas complementarias: el diagnóstico es clínico. Si existen dudas, se solicita ecografía.

Tratamiento: quirúrgico. Conservador sólo en caso de pacientes mayores con baja demanda.

BIBLIOGRAFÍA

- Mc Rae. Ortopedia y fracturas de bolsillo. (Temas 19, 20 y 21)
- Campbell. Cirugía ortopédica. Tomo 6. Fracturas y luxaciones. (Capítulo 54)
- Rockwood & green's. Fracturas en el adulto. (Sección II, temas 21 – 30)